Processo nº 0136738-21.2024.8.17.2001

AUTOR(A): GERSON ACCIOLY ROCHA

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de **ação sob o procedimento comum** ajuizada por e **GERSON ACCIOLY ROCHA**, através de advogada habilitada (ID 189769991), em face **BRADESCO SAÚDE S/A**, com pedido de tutela provisória de urgência para compelir a ré a autorizar "*o tratamento com o medicamento Stelara (ustequinumabe), indução com 390 mg, seguido de 90 mg/sc a cada 8 semanas – em ambiente hospitalar, em regime de hospital-dia (respeitando-se a refrigeração da droga e a disponibilidade de cuidados médicos), indicado pelo médico assistente, visto ser portador de Doença de Crohn*" (laudo médico de ID 189769988).

À saída, a parte autora informou não ter interesse na realização de audiência de conciliação e requereu prioridade de tramitação, com fundamento nos arts. 71 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e 1.048, I, do CPC/2015, por ser o autor pessoa idosa de 61 anos (ID 189769993) e portador de doença grave – Doença de Crohn (laudos IDs 189769989 e 189769988).

Segundo a inicial, o autor é beneficiário de plano de saúde individual da ré – Multi TOP, conforme cartão do plano de saúde de ID 189769992 (nº 045 544 121985 004) – há mais de 30 anos, adimplente com as mensalidades, no valor atual de R$ 2.827,42 (ID 189769985), portador de Doença de Crohn, diagnosticado em outubro deste ano (laudo de ID 189769989), vem sofrendo com a doença desde agosto, apresentando queda do estado geral – diarreia crônica, perda severa de peso corporal (perdeu 10kg em menos de 90 dias), crises diárias de hemorroidas com sangramento, dores nas articulações e no esqueleto – com restrições alimentares, pois a doença causa ileíte ulcerativa.

Diante do quadro de saúde do segurado – *Doença de Crohn, escore do índice de Harvey Bradshaw 09, sem tratamentos anteriores* – foi solicitado pelo gastroenterologista assistente, Roberto Magalhães Filho, CRM PE 11512, RQE 14848 e RQE 14903, tratamento com o

medicamento "*Stelara (Ustequinumabe), indução com 390 mg, seguido de 90 mg/SC a cada 8 semanas*", consignando que "*a não utilização da medicação supracitada incorre em aumento do risco de morte pela doença*", conforme laudo médico ID 189769988.

Além disso, o médico ainda pontuou que "*a infusão da droga na dose endovenosa (primeira dose), deve ser realizada em ambiente hospitalar, no regime de hospital-dia, respeitando-se refrigeração da droga, bem como a disponibilidade de cuidados médicos em caso de efeitos adversos graves da droga*" (ID 189769988).

A exordial informou que o medicamento prescrito se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Número de Regularização 112363394. No entanto, ao solicitar autorização para o tratamento à operadora de planos de saúde (OPS), adveio a negativa da ré (ID 189769987), comunicando "*a impossibilidade em atender a cobertura pleiteada, uma vez que esta despesa não é passível de cobertura, conforme previsto na Cláusula de Despesas Excluídas/Não Cobertas*".

Outrossim, alegou que o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) teve sua taxatividade modificada pela Lei nº 14.454/2022, a qual determinou que os planos de saúde deverão financiar tratamentos que não estiverem na lista mantida pela ANS. Assim, ao argumento de que a negativa perpetrada pela ré foi abusiva, propôs a presente demanda, pugnando pela concessão de tutela provisória de urgência antecipada.

No mérito, requereu: **(1)** a confirmação da tutela antecipada; **(2)** que seja declarada a nulidade da cláusula que restringe o direito do autor; e **(3)** a condenação da ré em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; ressarcir as custas e despesas processuais; e pagar honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, §§2º,8º e 14, do CPC/2015.

Fundamentou o pleito na Constituição Federal/CF (arts. 37, §6º, 170, 196 e 197), no Código de Defesa do Consumidor/CDC) (arts. 6º, 14, 22, 51, incisos I e IV, 54, 183), na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Súmula 35 do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no Código Civil/CC (arts. 186, 187 e 927), além de jurisprudências do STJ e de tribunais pátrios.

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00, sobre o qual fez o recolhimento das custas iniciais, conforme a respectiva guia e comprovante de pagamento (IDs 189842451 e 189842456). No mais, além dos documentos já citados, juntou as condições gerais do seguro saúde do autor (IDs 189770004 e 189770005).

Decisão inaugural (ID 190052274): **(1)** deferiu a tramitação prioritária (arts. 71 do Estatuto do Idoso e 1.048, I, do CPC/2015); **(2)** corrigiu o valor da causa para R$ 43.929,04 (art. 292, II, c/c §2º, do CPC/2015; e **(3)** determinou que a Diretoria Cível: **(a)** retificasse o valor da causa no sistema PJE; **(b)** intimasse o autor para pagar as custas complementares; e **(c)** realizado o pagamento, procedesse com a intimação/citação da ré, por mandado, para falar sobre o pedido de tutela, <u>no prazo de 2 (dois) dias</u>, devendo esclarecer qual a cláusula contratual que sustenta a negativa ao fornecimento do tratamento medicamentoso pleiteado pelo autor, bem como, querendo, ofertar contestação no prazo legal.

Retificado o valor da causa (certidão de ID 190310319), e expedida intimação da decisão inicial (ID 190310331), a parte autora requereu a intimação/citação da ré por meio eletrônico, nos termos dos arts. 246, §1º, do CPC, 7º, §3º, da Instrução Normativa nº 09/20 do TJPE, e 9º, da Lei nº 11.419/2004, indicando os endereços eletrônicos: <u>lucas.a.gomes@bradescoseguros.com.br</u>

(mailto:lucas.a.gomes@bradescoseguros.com.br) e judicial@bradescoseguros.com.br (mailto:judicial@bradescoseguros.com.br) (ID 190328500), e juntou a guia das custas complementares e o respectivo comprovante de pagamento (IDs 190372587 e 190372596).

A Diretoria Cível certificou, no ID 190642470, o pagamento das custas complementares e expediu mandado de citação/intimação da ré (ID 190642470), cujo cumprimento foi certificado pela oficiala de justiça no ID 190706440.

No ID 191058880, certificou-se o decurso do prazo para a ré se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, sem que esta tenha se pronunciado nos autos.

Decisão interlocutória de ID 191425506: (i) concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento com a medicação Stelara, indução com 390 mg, seguido de 90 mg/sc a cada 8 semanas; (ii) determinou que se aguardasse o decurso de prazo de 15 dias para oferecimento de contestação, intimando-se, em sucessivo, a autora para réplica e ambas as partes para indicarem interesse na produção de provas.

A parte ré, Bradesco Saúde S/A, informa a apresentação de **Agravo de Instrumento nº 0000128-64.2025.8.17.9000,** em face da decisão concessiva da tutela, requerendo o exercício do juízo de retratação.

Em seguida ofertou **contestação** no ID 192930990, aduzindo, para tanto, em síntese: (i) o plano de saúde do autor é individual, antigo e não adaptado, razão pela qual não há incidência da Lei 9.658/98, nem do Rol da ANS, mas apenas das normas contratuais; (ii) o fármaco prescrito é off label, pois não consta da bula a prescrição para tratamento da doença da qual é portador o autor, inclusive com aplicação do Tema 990 do STJ, que ao tratar da licitude das exclusões contratuais para fornecimento de medicamentos não nacionalizados, também esclareceu que é lícita a exclusão para tratamentos experimentais; (iii) há a cláusula 7, item a, das condições gerais do contrato, que exclui de cobertura medicamentos ainda não reconhecidos pelos órgãos governamentais competentes e sociedades médico-científicas brasileiras, ou seja, não reconhecido pela ANVISA para o fim pretendido; (iv) a cláusula 3 das condições gerais prevê que não haverá pagamento ou reembolso de medicamentos fornecidos ou aplicados pela entidade hospitalar ou para-hospitalar em regime ambulatorial, quando esses medicamentos não se destinarem a tratamentos de urgência; (v) inexistência de dano moral, pois a parte autora não teve desconforto psicológico ao ponto de abalar sua dignidade, somando-se ao fato de que eventual descumprimento contratual, não gera dano moral.

Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais, e acaso haja acolhimento, que o valor do dano moral não ultrapasse um salário-mínimo.

Após intimação para indicação de provas a produzir, o plano de saúde informa que não tem interesse, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 195480187).

A parte autora, por seu turno, apresenta réplica no ID 196745336, pugnando pelo julgamento antecipado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a analisar e decidir.

Verifica-se, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova em audiência, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente

instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art.355, I, do CPC/2015.

Cumpre registrar, de início, que o plano de saúde do autor é anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, o afasta a incidência da Lei 9.656/98 ao caso concreto.

Os contratos de plano de saúde, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da **Súmula 608**: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

O cerne da questão ora posta em pretório centra-se em averiguar se a operadora de saúde demandada possui a obrigação de fornecer o tratamento prescrito ao autor com Stelare (Ustequinumabe), indução com 390 mg, seguido de 90 mg, a cada 08 semanas, em razão de diagnóstio de doença de Crohn, escore do índice de Harvey Bradshaw 09.

A operadora de saúde invoca as seguintes teses de defesa: (i) o fármaco prescrito é off label, pois não consta da bula a prescrição para tratamento da doença da qual é portador o autor, inclusive com aplicação do Tema 990 do STJ, no qual restou esclarecido que é lícita a exclusão para tratamentos experimentais; (ii) há a *cláusula 7, item a*, das condições gerais do contrato, que exclui de cobertura medicamentos ainda não reconhecidos pela ANVISA para o fim pretendido; (iii) a *cláusula 3* das condições gerais prevê que não haverá pagamento ou reembolso de medicamentos fornecidos ou aplicados pela entidade hospitalar ou para-hospitalar em regime ambulatorial, quando esses medicamentos não se destinarem a tratamentos de urgência.

De início, compulsando os autos, depreende-se dos documentos juntados aos autos pela parte demandante, laudo do gastroenterologista assistente, Roberto Magalhães Filho, CRM PE 11512, RQE 14848 e RQE 14903, apontando a grave enfermidade que acomete o autor – Doença de Crohn, escore do índice de Harvey Bradshaw 09, sem tratamentos anteriores – e a necessidade do tratamento com o medicamento "*Stelara (Ustequinumabe), indução com 390 mg, seguido de 90 mg/SC a cada 8 semanas*", consignando que "*a não utilização da medicação supracitada incorre em aumento do risco de morte pela doença*" (laudo médico ID 189769988). Ademais, a infusão da droga na dose endovenosa, deve ser realizada em ambiente hospitalar, no regime hospital-dia, respeitando-se refrigeração da droga, bem como a disponibilidade de cuidados médicos em caso de efeitos adversos graves da droga.

De proêmio, impende registrar que é entendimento firmado pela Corte da Cidadania de que "*considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label)*" (AgInt no AREsp 1682588/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Neste sentido, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. **PLANO DE SAÚDE**. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO**. NEGATIVA INDEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3. **A jurisprudência do STJ considera abusiva a recusa do plano de saúde de custear medicamento prescrito pelo médico, mesmo que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), pois não compete à operadora definir o diagnóstico ou tratamento para a moléstia coberta pelo plano**.

4. Não cabe recurso especial fundado em ofensa a verbete sumular, conforme a Súmula n. 518 do STJ, e a parte agravante não demonstrou o dissídio jurisprudencial necessário para o conhecimento do recurso pela alínea "c" do art. 105, III, da CF.

III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "**1. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear medicamento prescrito pelo médico, mesmo que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label).**

"Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.487/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024;

STJ, AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.964.268/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023**.(AgInt no REsp n. 2.142.211/MT**, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de **21/2/2025.**)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCECAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. **RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF LABEL -. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR**. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. (...) 3. **O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental**. 4. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. **(AgInt no AREsp 1683820/SP**, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, **DJe 10/03/2021**)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.** INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "**Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Incidência da Súmula 83 do STJ**" (AgInt no REsp 1.680.415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe de 11/09/2020). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (**AgInt no REsp 1875974/SP**, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe **17/12/2020)**

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, "*os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados*" (AgInt no AREsp 1678991/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, não se mostra razoável a recusa de custeio efetuada pela seguradora, mormente quando a medicação pretendida se perfaz no tratamento indicado à doença listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da OMS, qual seja: doença de Crohn, CID K50.

Para além disso, deve ser observado que apesar de se tratar de contrato antigo não adaptado, em face da incidência da legislação consumerista, em especial o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), é possível se aferir no contrato original e nas suas renovações a abusividade de cláusulas contratuais.

As cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelas seguradoras, notadamente aquelas às quais os consumidores aderem por força da própria natureza adesiva do contrato, devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da equidade, e na forma do que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta toada, porquanto o contrato firmado entre as partes visar a prestação de serviços à saúde, havendo previsão de cobertura para a doença que o paciente apresenta, é justa a expectativa de cobertura para o tratamento médico que lhe for recomendado.

Enfim, ***as cláusulas 7, item a e 3,*** invocadas para negativa de cobertura, se afiguram abusivas, pois nos termos da jurisprudência do STJ: "**é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental",** sendo esta a situação do caso vertente.

Deste modo, evidencia-se a obrigação da operadora de saúde demandada arcar com o custeio do tratamento medicamentoso prescrito à autora pelo médico assistente sendo, pois, procedente a obrigação de fazer.

Registro, por oportuno, que não é o caso de aplicação do Tema 990 ao caso em epígrafe, que se encontra assim sedimentado: "*As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA."*

Isso porque no caso em epígrafe não trata de custeio de medicamento sem registro na Anvisa, pois aqui existe o registro, não havendo que se falar em fase experimental. A temática, na verdade, invocada na defesa, é o uso off label, ou seja, **fora das hipóteses previstas na bula.**

Em sendo assim, não merece acolhida nenhuma das teses de defesa suscitadas pela ré, restando, por conseguinte, **inacolhido o pedido de retratação.**

Quanto ao pedido de indenização por **danos morais**, este também é procedente.

Há de se pontuar que a parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que estava acometida de doença grave, necessitando submeter-se ao procedimento medicamentoso indicado.

Suportando o autor não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico com a não autorização não se limitou a mero aborrecimento.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento etc.

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL TIRADO DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. PLANO DE SAÚDE. **RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA (IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO). DANO MORAL CONFIGURADO**. 1. **A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença**. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1614203 RJ 2016/0186519-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017).

> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.** <u>PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS.</u> ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. **DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1**. (...) 2**. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, <u>porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida</u>, esclarecendo, ainda, que tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.** 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, realizado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no

sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. **É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais**. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. **(AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)**

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o desgaste emocional suportado pela autora, nos termos do art. 944, do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em **R $3.000,00 (três mil reais).**

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que a ré autorize autorize e custeie o tratamento com a medicação "*Stelara (Ustequinumabe), indução com 390 mg, seguido de 90 mg/SC a cada 8 semanas*", conforme prescrito pelo médico assistente no laudo de ID 189769988, **ratificando a tutela antecipada de ID 191425506.**

2) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, arbitrado em **R$ 3.000,00 (três mil reais),** quantia a ser corrigida monetariamente pela tabela ENCOGE, a partir da data desta sentença (Súmula 362, do STJ), e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e obrigação de fazer, referente ao tratamento prescrito, em atendimento a Súmula 199 do TJPE, limitado ao período de 12 meses), na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Oficie-se ao Relator do Agravo de Instrumento 0000128-64.2025.8.17.9000, dando ciência da presente sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Recife, 17 de março de 2025

Virgínia Gondim Dantas
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
17/03/2025 11:16:31
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 197935863

25031711163141000000192880275

IMPRIMIR GERAR PDF